

Protocolo Clínico – 6 a 8 semanas

Hipertensão Intracraniana Idiopática (HII) com foco no sistema glinfático

Objetivos terapêuticos

- Otimizar a drenagem glinfática cerebral
- Reduzir a pressão venosa intracraniana funcional
- Restaurar sono NREM profundo
- Reduzir neuroinflamação metabólica
- Diminuir cefaleia, brain fog e risco de papiledema

Avaliação basal (Semana 0)

- Cefaleia: intensidade, padrão matinal/noturno
- Sintomas visuais e papiledema
- Qualidade do sono e suspeita de apneia
- Exames úteis: HOMA-IR/TyG, ácido úrico, ferritina, vitamina D

Semanas 1–2: Destravamento glinfático

- Sono regular, decúbito lateral, evitar álcool e refeições noturnas volumosas
- Respiração nasal lenta diária; evitar Valsalva e apneias voluntárias
- Hidratação adequada ao longo do dia

Semanas 3–4: Reorganização metabólica

- Redução de carboidratos refinados e jantar mais leve
- Controle de hiperinsulinemia e gordura visceral
- Exercício aeróbico leve a moderado; evitar força com Valsalva

Semanas 5–6: Otimização glinfática

- Exercício aeróbico contínuo (zona 2–3), 30–45 min, 4–5x/semana
- Consolidação do sono profundo e revisão de despertares
- Evitar fatores de aumento sustentado de pressão intratorácica

Semanas 7–8: Estabilização e decisão

- Reavaliar cefaleia, sintomas visuais e qualidade do sono
- Se refratário: investigar apneia não tratada e estenose de seios venosos
- Manter integração com tratamento neurológico e oftalmológico

Mensagem-chave: HII é falha de drenagem integrada. Sem tratar sono, inflamação e metabolismo, a pressão tende a recidivar.